

Información Paciente

Nombre : Jose Roberto Castro Oporto
Edad : 69a 3m 15d
Dirección : Bahía Navidad 1606

Rut : 6.654.103-7
Fecha Nacto: 22/06/1953
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1721057
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 8471 4290

N° Epicrisis
325779

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Utim

Fecha Ingreso : 30/09/2022 00:55

Días Estadía : 7

Unidad de Egreso : Hospital De Campaña - Camas Básicas

Fecha Egreso : 07/10/2022 10:10

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor y aumento de perímetro abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: José Roberto Castro Oporto
Edad: 69 años
RUN: 6.654.103-7
FI HSR: 29/09/22
FI UTIM: 30/09/22
FI HM: 03/10/22

ANTECEDENTES:

- Médicos: Cirrosis Child-Pugh A por OH, Várices esofágicas grandes ligadas 01/08/22, HTA, DM2, Sífilis latente tardía tratada
- Quirúrgicos: colecistectomía abril/2019
- Fármacos: Omeprazol 20mg c/12h, Propanolol 20mg/d, Lactulosa 30cc c/8h, Metformina
- Alergias: no
- Hábitos: tabaco suspendido hace 2 meses, previamente IPA 14.7; OH suspendido hace 2 meses, drogas no
- Hospitalizaciones recientes: 19/07 al 01/08/22 por shock hipovolémico por HDA masiva no variceal. Requirió tx 2UGR, IOT + VMI por 5 días. Se realizaron 3 EDAs: Úlcera FIII en cuerpo y otra en antro, gastropatía universal severa y erosiva en antro. VE grandes con signos de riesgo, se realiza ligadura con 3 bandas elásticas (01/08/22).

MOTIVO DE CONSULTA: dolor y aumento de perímetro abdominal

HISTORIA: Paciente con antecedentes descritos y hospitalización reciente (se fue de alta 01/08) por shock hipovolémico por HDA masiva no variceal, donde además se ligaron VE grandes con signos de riesgo. Había quedado con indicación de nueva EDA en ambulatorio para erradicación del resto de várices, la que se realizó 07/09/22: VE pequeñas con signos de riesgo. Cicatrices de ligaduras de várices esofágicas en esófago distal. Aspecto de Pangastropatía eritematosa. Bulboduodenitis

Consultó en UEA el 21/09 por ascitis y disnea, se descartó PBE y se realizó paracentesis evacuadora (4L), al alta con indicación de Espironolactona.

Ahora consulta por cuadro de 3 días de evolución de aumento del perímetro abdominal asociado a dolor en hipocondrio derecho a la inspiración profunda y disnea de esfuerzos moderados.

A su ingreso en UEA: FC 64 - PA 97/72 - PAM 80 - T° 36.6 - SatO2 98% amb

Fecha Epicrisis : 07/10/2022 13:29

Fecha Última Actualización: 07-10-2022 13:29:30

Página 2 de 3

Al examen físico se describe vigil, OTE, escleras con tinte icterico, hidratado y bien perfundido, cardiopulmonar normal. Abdomen globuloso, blando, depresible, sensible en hipocondrio derecho, sin signos de irritación peritoneal, matidez en flancos +++, desplazable, edema de EEII +/-++.

Exámenes de ingreso:

- Lab: glic 124 - Na 137 - K 4.93 - Cl 106 - Crea 1.33 (crea del 29/07/22 en 0.65), - BUN 23.7 - Hto 30.9 - Hb 10.2 - GB 7260 - RAN 5280 - RAL 1140 - PlaQ 220000 ¿ INR 1.34 - BT 1.02 - BD 0.57 - FA 286 - GPT 57 - GOT 68 - GGT 389 - Alb 2.4 - Prot 7.2 - AFP 20.000 - APE 11.65
- TAC AP 30/09: DHC con signos de hipertensión portal. 3 lesiones focales hepáticas con caracteres de hepatocarcinoma y otras pequeñas lesiones focales hipervasculares, que podrían ser mejor caracterizadas con RM. Signos de trombosis de la vena porta principal y sus ramas intrahepáticas. Abundante ascitis.
- TAC tórax 30/09: pendiente informe.

Dado falla renal, se inicia manejo con albúmina, no se logra realizar paracentesis diagnóstica por falta de bolsillo puncionable. Se inicia anticoagulación con HBPM.

Evaluado por Gastro: "se presentará en reunión de lesiones, se solicita TAC tórax y AFP para completar estudio"

Se traslada a UTIM para continuar manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

- HCC debut
- Trombosis portal en anticoagulación
- AKI KDIGO II
- Antecedentes

EVOLUCIÓN POR PLANES:

HEMODINAMIA: Estable, autosostenida, por falla renal y ascitis a tensión recibió volemicización con albúmina hasta el 02/10. Caída de Hb 10.1 a 8.5 sin exteriorizar sangrado, se interpreta como dilución por volemicización dada estabilidad. Con PBE descartada, se inicia terapia depleitiva para BH -500. Sin nueva caída de Hb.

VENTILATORIO: no es conflicto, sin disnea ni requerimientos de O2.

INFECCIOSO: afebril, PCR hasta 84.9 en disminución espontánea hasta 45, sin ATB.

GASTRO: antecedente de DHC por OH. Por problemas:

- VE: cursó con HDA hace 2 meses, de origen no variceal. De todos modos, se hizo nueva EDA hace 1 mes con VE pequeñas con signos de riesgo, várices grandes habían sido ligadas. BB reiniciado en titulación para FC 55-60 lpm.
- EH: Sin EH, se mantiene lactulosa en titulación para 2-3 dep/día.
- Ascitis/PBE: Ascitis G II-III. El día 02/10, se realiza paracentesis diagnóstica con 218 cells 55% PMN y se reinicia terapia depleitiva a dosis bajas. Con dolor abdominal difuso por lo que el 06/10 se realiza nueva paracentesis diagnóstica que descarta PBE.
- SHR: Crea basal 29/07 en 0.65, ingresa con AKI crea 1.51. Buena respuesta a albumina, por lo que se suspende el día 02/10. Vigilancia. Dado labilidad de función renal, equipo de Nefrología sugiere que ante paracentesis evacuadora sin importar los litros extraídos se realice reposición con albúmina 8g por litro.
- Hepatocarcinoma: TAC AP de ingreso con 3 lesiones sospechosas de HCC y otras pequeñas lesiones focales hipervasculares. RM del 04/10 informa: al menos 4 lesiones hipervasculares bilobares. Hepatocarcinoma infiltrativo, con signos de trombosis tumoral de vena porta intrahepática izquierda y derecha. Trombosis blanda de vena porta principal y vena mesentérica superior.

Se solicita TAC de tórax 30/09, negativo para siembra a distancia. Informa: Leve enfisema pulmonar, banda atelectásica cicatricial en el LSI, atelectasia casi completa del LM y del segmento basal anterior del LID.

AFP 20.000

Fue presentado en comité oncológico. Queda en plan de control al alta con gastroenterología (Dra Norero) para decidir en conjunto de oncología, posibilidad de TS vs ingreso directo a CCPP.

- Trombosis portal: trombosis de la vena porta principal y sus ramas intrahepáticas en imágenes. Se inicia anticoagulación con enoxaparina durante la hospitalización, se suspende previo al alta según sugerencia de especialista.

Diagnóstico de Egreso

Fecha Epicrisis : 07/10/2022 13:29

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 07-10-2022 13:29:30

Página 3 de 3

Carcinoma De Células Hepáticas -
Fibrosis Y Cirrosis Del Hígado - Etiología Oh
Trombosis De La Vena Porta -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Paciente en BCG, HDNE, normotenso, normocárdico, sin req O2. Niega disnea. Con apósito en zona de paracentesis diagnóstica en FII. Ascitis GII en disminución.
Abdomen sensible a la palpación. Laboratorio del 06/10 descarta PBE.

Plan Post Alta

Régimen hiposódico
Suspender consumo de alcohol
Reposo relativo

Medicamentos:

Propanolol 10 mg cada 12 horas VO
Furosemida 40 mg al día VO
Espironolactona 50 mg al día VO
Lactulosa 30 cc cada 8 horas VO. Ajustar dosis para lograr 2-3 deposiciones pastosas al día.
Omeprazol 20 mg cada 12 horas VO

Controles:

Con gastroenterología (Dra Norero) en CDT. Se entrega copia de interconsulta.

Consultar en urgencia en caso de sangrado, fiebre, aumento del tamaño abdominal, dolor abdominal intenso, desorientación o somnolencia excesiva.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Levantar Diariamente

Régimen Alimentario : Común

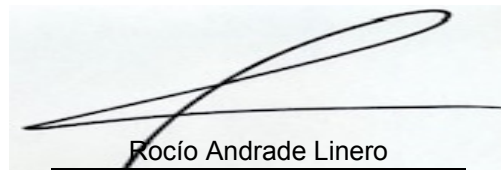
Medicamentos :

Controles

14/10/2022 - CDT - Gastroenterología Adulto - Dra Norero

INTERNO

Becado/Residente



Rocío Andrade Linero
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 07/10/2022 13:29

Página 3 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 16:14

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar